

Adenopatías en Pediatría

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
PRONAP 2002, SAP

En la mayoría de las circunstancias, las adenomegalias están vinculadas a infecciones comunes y en muy pocos casos están asociadas a cáncer u otras patologías de significación

CONCEPTO:

> 1 cm en ganglios cervicales y axilares

> 1,5 cm en inguinales

> 0,5 cm en epitrocleares

Se consideran patológicos en las regiones:

- Supraclavicular:
 - Relacionadas con procesos malignos hasta en el 75% de los casos
 - La localización derecha se asocia a procesos mediastínicos o pulmonares
 - La localización izquierda (nódulo de Virchow) suele hacerlo con procesos abdominales, sobre todo linfomas.
 - Latuberculosis, histoplasmosis y coccidiomicosis también pueden afectar esta región
- Retroauricular
- Poplítea
- Ilíaca
- Mediastínicas o abdominales (por Rx)

Etiologías infecciosas de adenopatías en pediatría

	ETIOLOGÍAS	LOCALIZACIONES			
		Cervical	Mediastinal	Abdominal	Generalizadas
Bacterianas	Staphylococcus aureus: adenitis aguda	*			
	Streptococcus grupo A: adenitis aguda	*			*
	M. tuberculosis: TBC	*	*	*	*
	Bartonella henselae: arañazo de gato	*	*	*	
	Bacterias anaerobias	*			
	Vacuna BCG: becegeftis				
	Enterobacterias Gram – negativas	*			
	Treponema pallidum: sífilis	*			*
	Micobacterias atípicas	*	*	*	*
Virales	Virus de Epstein-Barr: mononucleosis	*		*	*
	Citomegalovirus	*			*
	Herpes simplex	*			
	Varicela	*			*
	Adenovirus	*			*
	HIV	*			*
	Sarampión	*			*
	Paperas	*			
	Rubeola	*			*
	Coxsackie	*			*
Micosis	Blastomicosis	*	*	*	*
	Histoplasmosis	*	*		*
	Esporotricosis	*			
Parasitarias	Toxoplasmosis	*	*	*	*
	Toxocariasis	*		*	

Etiologías oncológicas

		LOCALIZACIONES			
	ETIOLOGÍAS	Cervical	Mediastinal	Abdominal	Generalizadas
Enfermedades malignas	Enfermedad de Hodgkin	*	*	*	*
	Linfoma no Hodgkin	*	*	*	*
	Leucemia	*	*	*	*
	Metástasis: Carcinoma tiroideo	*			
	Neuroblastoma	*			*
	Rabdomiosarcoma	*		*	
	Carcinoma nasofaríngeo	*			

Clasificación

- **Adenopatía localizada:** compromiso de un solo grupo ganglionar en una sola región
- **Adenopatías regionales:** compromiso de dos o más grupos ganglionares en la misma región o de uno o más grupos en dos o más regiones contiguas
- **Adenopatías generalizadas:** aumento del tamaño ganglionar linfático en más de dos regiones no contiguas.
- **Agudas:** Hasta 1 mes
- **Subagudas:** 1-3 meses
- **Crónicas:** >3 mes

Características

Dolor:

- Indoloros: de etiología viral más frecuente, pero el 90% ganglios neoplásicos son indoloros.
- Dolorosos: benignos: 67%, en general de etiología bacteriana.

Evolución

- Días o pocas semanas:

Suelen estar vinculadas a infecciones comunes o proceso reactivo. Pero si el aumento del tamaño es notable y ocurre en una a tres semanas, sin dolor y con pegote de ganglios, puede sugerir enfermedad maligna.

- Subaguda crónica, sin signos inflamatorios:

Es más probable que se trate de enfermedad granulomatosa o neoplásica

Tamaño:

Medición y registro: si no se realizó previamente la medición, es muy útil saber si la familia notó cambios en el tamaño de la adenopatía

Tipos:

1. Adenitis cervical aguda

El término adenopatía hace referencia a alteraciones del tamaño y/o la consistencia de los ganglios linfáticos, cuando aparecen signos inflamatorios locales hablamos de **adenitis**.

En la edad pediátrica la mayoría de las adenopatías son reactivas a infecciones respiratorias, principalmente de etiología vírica.

A- Adenopatía aguda bilateral

Forma más frecuente debida, en la mayoría de los casos, a virus respiratorios.

Las adenopatías reactivas a estas infecciones suelen ser pequeñas y sin signos inflamatorios, no supuran y tienen un curso autolimitado, aunque en algunos casos pueden persistir durante semanas.

- Infección por VEB: el 95% presentan adenopatía cervical
- Infección por CMV: el 75% presentan adenopatía cervical.

Su tamaño varía entre 0,5 y 2,5 cm y se afectan con más frecuencia los ganglios cervicales posteriores.

La faringoamigdalitis es más frecuente en la infección por VEB, mientras que la hepatoesplenomegalia y el exantema se asocian principalmente a CMV.

- El adenovirus se caracteriza por fiebre, faringitis y conjuntivitis.
- La gingivostomatitis por VHS cursa con fiebre, úlceras orales, eritema gingival y adenopatías laterocervicales y submandibulares dolorosas.
- La adenitis cervical bilateral aguda también aparece en el 25-50% de los niños con rubéola, exantema súbito (herpes 6) e infecciones por Coxsackie. En la rubéola suelen aparecer las adenopatías antes del exantema característico

B- Adenitis aguda unilateral

Relacionada principalmente con infecciones bacterianas. Habitualmente son adenopatías de tamaño mayor a 2-3 centímetros y curso agudo (generalmente 5 días o menos), dolorosas a la palpación, presentando signos inflamatorios locales en la mayoría de los casos.

***S. aureus* y *S. pyogenes*:** más del 80% de los casos, las infecciones por estas bacterias son más frecuente en preescolares, secundarias a foco infeccioso orofaríngeo o cutáneo. La complicación más frecuente es la abscesificación, que aparece en el 10-25% de los casos, principalmente en los debidos a *S. aureu*.

***Streptococcus agalactiae*:** en lactantes menores de 3 meses hay que considerar la posibilidad de síndrome celulitis-adenitis, que cursa con fiebre, afectación del estado general e inflamación cervical con celulitis de la piel suprayacente. La región submandibular es la más frecuentemente afectada.

Este síndrome se considera una forma de sepsis tardía por *S. agalactiae* y requiere estudio completo de sepsis incluyendo punción lumbar.

Celulitis periganglionar o adenoflemón: si la infección es de origen dentario suele ser provocada por bacterias anaerobias. Presentan adenomegalias habitualmente grandes, de hasta 6 cm de diámetro, casi siempre tienen signos de flogosis.

2. Adenopatías cervical subaguda/crónica

Aparece con más frecuencia en escolares y adolescentes y suele estar en relación con infecciones por VEB, CMV, micobacterias atípicas, tuberculosis y enfermedad por arañazo de gato.

La afectación habitualmente es bilateral en VIH y toxoplasmosis, unilateral en micobacterias no tuberculosas y enfermedad por arañazo de gato y variable en tuberculosis

A- Adenitis tuberculosa

Suele afectar a niños mayores y a menudo se acompaña de fiebre y otros síntomas constitucionales.

La adenitis es, a veces, bilateral y puede afectar a cadenas cervicales posteriores, axilares y supraclaviculares. El 28-

70% de los pacientes presenta alteraciones en la radiografía de tórax

B- Enfermedad por arañazo de gato

Provocada por un bacilo Gram negativo, la bartonella henselae

La enfermedad se adquiere por rasguño, mordedura o beso (lamida) de gatos, habitualmente cachorros (95% de los casos); y muy rara vez por contacto con perros u otros animales.

La lesión cutánea inicial se forma entre 5 y 10 días del inóculo, consiste en una pápula dura (secundaria a uno o múltiples rasguños) que evoluciona a pústula y costra

Luego de una a ocho semanas posteriores, se detectan las linfadenopatías, los ganglios axilares y cervicales son los más afectados

Los ganglios son de tamaño mediano, pero a veces voluminosos, de aspecto sólido y algo doloroso.

Es habitualmente autolimitada; la evolución suele durar de 1 a 3 meses y por excepción hasta un año.

Puede aparecer síndrome febril prolongado asociado a adenomagalias abdominales y granulomas en hígado, bazo y riñones, con leucocitosis neutrófila y ERS muy acelerada. Otras manifestaciones incluyen: exantemas, eritema nodoso, púrpura trombocitopénica, derrame pleural, lesiones osteolíticas, retinitis y encefalopatía.

El diagnóstico suele hacerse por los antecedentes y la clínica.

Valorar tratamiento con azitromicina 10 mg/kg/24 horas v.o. durante 5 días en pacientes con clínica sistémica. Si hay supuración, la punción aspirativa puede disminuir el dolor

C- *Toxoplasma gondii*

La primoinfección es normalmente asintomática, aunque en un 10% produce adenitis cervicales sin tendencia a la supuración ni signos inflamatorios locales

Internación:

- Obligatoria para los lactantes menores 3 mes
 - Conveniente para menores de 2 años
 - Niños de más edad con gran compromiso local o general, con riesgo de complicaciones
 - Inmunosuprimidos
-
- Cefalotina EV a 100 mg/kg día
 - Ampicilina-Sulbactam a 150 mg/Kg/día en adenoflemon
 - Según las normas para infecciones sistémicas en los casos de neonatos y lactantes pequeños

3. Adenitis por vacuna BCG ("becegeítis")

Del 0,1 al 1% de los receptores inmunocompetentes de esta vacuna presentan ulceración cutánea y/o adenitis regional.

La adenopatía aparece entre 1 y 3 meses de recibida la vacuna, aunque hemos visto que puede detectarse a lo largo de todo el primer año de vida.

El ganglio se localiza en el hueco axilar o vecino a él. Si la aplicación de la BCG es muy cercana al hombro puede observarse adenitis subclavia o supraclavicular

El aspecto es sólido, duro-elástico y no duele.

La evolución se hace en forma subaguda o crónica.

El aumento de tamaño se suele acompañar de coloración violácea y adherencia a la piel, ésta se adelgaza, se fistuliza y se produce la evacuación de caseum durante varias semanas. Se logra así la curación espontánea.

Rara vez la adenomegalia alcanza gran tamaño (3 a 4 cm), no se fistuliza y se deposita calcio en ella, visible en las Rx. Sólo en estas situaciones, y por razones estéticas, puede ser necesaria la extirpación quirúrgica.

Algoritmo de actuación ante linfadenopatías

Localizada aguda

Indoloras
Bilaterales
De pequeño tamaño
Síntomas inf. locales

Probable adenopatía reactiva o vírica de vías respiratorias altas:

- Enterovirus
- Adenovirus
- Influenza
- Herpes simple
- Herpesvirus tipo 6

Tto. sintomático

Controles: 48hs, 7-14-31 días

Evolución

Persiste
>15 días

Pruebas complementarias

En casos que no mejoran tras 48 hs de tratamiento antibiótico correcto, se recomienda realizar ecografía para descartar la presencia de abscesificación

Unilateral
Caliente
Hipersensible
Eritema

Probable adenopatía Bacteriana:

- *Staphylococcus aureus*
- *Streptococcus pyogenes*
- Anaerobias: odontológicas

Tratamiento ATB 10-14 días ± drenaje

- Cefalexina: 80-100 mg/kg/día
- TMP-SMZ 8-12mg/Kg/día
- Clindamicina 20-30mg/Kg/día
- Amoxicilina-clav 50mg/Kg/día (odontógeno)

Ingreso hospitalario:

- Falta de respuesta el tratamiento antibiótico inicial en 48-72 h si presencia de abscesificación (en este caso: drenaje + Clindamicina)
- Afectación del estado general.
- Intolerancia a líquidos o a la medicación oral.
- Menor de 3 meses.
- Fiebre elevada en lactantes.
- Entorno familiar que no garantice el cumplimiento terapéutico.
- Sospecha de enfermedad de Kawasaki o enfermedad neoplásica

Localizada subaguda o

× Pruebas complementarias:

- Ecografía de adenopatías
- Hemograma - VSG - hepatograma - Bioquímica
- Serología:
 - VEB y CMV
 - *Bartonella henselae*
 - VIH
- Radiografía de tórax
- Prueba de la tuberculina
- Cultivo de exudados si hay faringitis

Diagnóstico etiológico

Etiología desconocida

Tratamiento específico

Sospecha de malignidad

Si

No

TAC – Eco -Biopsia

Aumenta en 2 semanas o no disminuye en 4-6 semanas o no se normaliza en 8-12 semanas

Si

No

Adenopatía reactiva

Linfadenopatías generalizadas

Síntomas y signos que indiquen una posible neoplasia maligna
Signos de obstrucción de la vía respiratoria
Síntomas generales prolongados
Aumento de tamaño progresivo e indoloro

Sí

No

Hemograma, VSG
Bioquímica (con LDH, ácido úrico, fosfatasa alcalina, calcio y fósforo)
Radiografía de tórax
Biopsia y estudios de médula ósea

Hemograma, VSG, Bioquímica incluyendo función hepática, Serología (CMV, VEB, toxoplasma, VIH y *Bartonella henselae*), Rx de tórax, ecografía
Exudado faríngeo si hay faringitis, prueba de la tuberculina